

HEMŞİRELİK ESASLARI

SOLUNUM SİSTEMİ SORULARI

1) Maske ile oksijen uygulamasında dikkat edilmesi gereken noktalardan 5 tanesini yazınız.

1. Hastanın yüzüne tam olarak oturan bir maske kullanılmalıdır.
2. Yüze yerleştirildikten sonra bağları sıkıştırılarak oksijen sızıntısının olmamasına dikkat edilmelidir.
3. Maskenin balonu derin inspirasyonda bile sönmemelidir.
4. Cilt tahrişi gözlenmeli, gerekli bakım (ağız, burun...) verilmelidir.
5. Maske ile uygulamada, hasta boğulma hissine kapılacağından istemeyebilir. Bir süre yanında kalınarak rahatlaması sağlanmalıdır.
6. Maske zaman zaman kaldırılarak cilt bakımı verilmelidir.
7. Oksijen maskesi, CO₂ retansiyonu fazla olan hastalarda kullanılmamalıdır.

2) Solunum yollarındaki sekresyonların çıkarılmasını kolaylaştıran uygulamalar nelerdir?

1. Hidrasyon,
2. nemlendirme- buhar verme,
3. nebulizasyon,
4. postural drenaj

3) Oksijen tedavisi sırasında gelişebilecek komplikasyonlar nelerdir?

1. Oksijene bağlı hipoventilasyon
2. atelektazi,
3. retrolental fibroplazi
4. oksijentoksitesi

4) Derin solunum egzersizi nasıl yapılır. Anlatınız.

- Hasta yatağında veya sandalyede rahat oturur pozisyona getirilir.
- Yatakta ise dizleri bükülerek abdominal kaslardaki gerginlik azaltılır
- Hastanın elleri kostaların altına, soluk alıp verdiği her iki yanda diyafragmayı hissedecek şekilde yerleştirilir.
- Hasta derin nefes alır, bu sırada kostaların altına yerleştirilmiş olan elleri orta parmakları birbirine değmelidir. Böylece inspirasyonda parmakların birbirinden uzaklaştığı hissedilir.
- 5'e kadar sayarak nefesini tutarak hasta daha sonra nefesini ağızdan yavaşça bırakır.

5) Öksürme mekanizmasını sırasıyla anlatınız.

- Derin bir inspirasyon
- Glottisin kapanması
- Solunum kaslarının aktif kontraksiyonu
- Glottisin açılması

6) Aspirasyon teknikleri nelerdir? Hangi durumlarda uygulanır?

- Orofarengeal ve nazofarengeal aspirasyon: Hasta etkili bir şekilde öksürebildiği, ancak tükürme veya yutmayla sekresyonları temizleyemediği zaman yapılır.
- Orotrakeal ve nazotrakeal aspirasyon: Pulmoner sekresyonları olan hasta öksüremediği ve suni bir havayoluna sahip olmadığı zaman yapılır.
- Yapay hava yolu aspirasyonu: Endotrakeal tüp veya trakeostomi tüpü gibi suni bir hava yolu yardımıyla gerçekleştirilir.

7) Oral airway hangi amaçla kullanılır? Hastaya uygun büyüklük nasıl belirlenir?

Oral airway, dilin orofarenks içine yer değiştirilerek trakeanın tıkanmasına engel olur.

Airway büyüklüğü, ağzın köşesinden kulağın hemen altındaki çene açısına kadar olan mesafe ölçülerek belirlenir.

8) Aspirasyon esnasında mukoz membranların zarar görme riskini ve hipoksemiye azaltmak için nelere dikkat etmek gerekir?

- Hasta için uygun aspirasyon basıncını ve aspiratör tipi seçilir.
- Uygun katater numarası seçilir.
- Aspirasyon kateteri yerleştirilirken aspiratör kapalı tutulur.
- Kateter, bağlantı tüpündeki sekresyonlar temizlenene dek küvet içindeki suyu aspire ederek çalkalanır.
- Kateterle trakea içine girerken aspirasyon basıncının uygulanmaması.
- Kateteri daha kolay giriş için kayganlaştırma.
- On saniyeden daha uzun sürmemesi.

9) Aspirasyon işleminin 10 saniyeden uzun sürmesi sonucu oluşabilecek komplikasyonlar nelerdir?

- Kardiyopulmoner fonksiyonları tehlikeye atabilir.
- Hipoksiye ve mukozanın yaralanmasına neden olabilir.

10) Solunum yollarının aspirasyonuna bağlı gelişebilecek komplikasyonlar nelerdir?

- 1) Hipoksi,
- 2) Mukoza travmaları,
- 3) Atelektazi,
- 4) Enfeksiyon,
- 5) Vagal stimülasyon (Nervus Vagusun uyarılması),
- 6) Kardiyak arrest,
- 7) Solunum arresti

11) Oksijen tedavisinde dikkat edilmesi gereken ilkelerden 5 tanesini söyleyiniz.

- 1) Oksijen vermek için doktor istemi olmalıdır.
- 2) Hastaya yapılacak işlem ve kullanılacak araç-gereç tanıtılmalıdır.

- 3) Oksijen uygulamadan önce hastanın solunum yollarının açık olup-olmadığı kontrol edilmeli, sekresyon varsa aspire edilmelidir.
- 4) Oksijen yanmayı hızlandıran bir gazdır. Küçük bir kıvılcım bile yangına neden olur. Hastanın odasına "Sigara içilmez" yazısı yazılmalı, sağaltım sırasında elektrikli araçlar kullanılmamalıdır. Ayrıca odada elektrik kaçağı olup-olmadığı kontrol edilmelidir.
- 5) Hastanın rahat edebileceği bir pozisyon verilir.
- 6) Oksijen tedavisinin uygulandığı tarih, başladığı saat, kullanılan yöntem, hastanın solunum ve nabız hızı kaydedilmelidir.
8. Oksijen sudan geçirilerek nemlendirilir. Nemlendirir haznenin 2/3'ünü veya ½ sini distile su veya steril serum fizyolojik ile doldurmak gerekir. Kuruluğa neden olacağı için hastalara ağız bakımı verilmelidir.
9. Oksijen tüpü kullanılıyorsa ikinci bir oksijen tüpü yedek olarak bulundurulmalıdır.
10. Hastanın fiziksel hijyeni ve rahatlığı ile oksijen kullanımı arasında ilişki vardır. Hasta rahatsız ve huzursuz olduğunda bazal metabolizma hızlanır ve oksijen gereksinimi artar. Hastanın hareket etmesine, fiziksel hijyenine yardım hastanın oksijen gereksinimini azaltır.
11. Hastanın duygusal rahatlığını sağlamak da hastanın oksijen gereksinimini azaltır. Korku, öfke, endişe vücudu kaçış veya mücadele hazırlayan savunma yanıtını başlatabilir. Hastanın endişeleri giderilmelidir.
12. Yüksek yoğunlukta oksijen uygulanan durumlarda oksijen sağaltımı birden kesilmemeli miktar yavaş yavaş azaltılarak hastanın atmosfer havasına alışmasına olanak tanınmalıdır.

12) Retrolental fibroplazi nedir?

Prematüre bebeklerde, yüksek yoğunlukta oksijen uygulamasının neden olduğu göz merceği arkasındaki bağ dokusu artımı, retinada ayrılma ve kalıcı körlük meydana getirebilen bir durumdur.

Erişkinlerde ise, oksijen yüksek konsantrasyonda verilirse kornea hasarına neden olur.

13) Oksijen toksitesi belirtileri nelerdir?

- Sırt ağrısı,
- Bulantı ve kusma,
- Ekstremitelerde uyuşukluk,
- Halsizlik,
- Kuru öksürük

14) Hastalara aspirasyon hangi durumlarda uygulanır?

Hasta öksürmeyle solunum yollarındaki sekresyonları temizleyemediği zaman uygulanır.

15) Oksijen uygulama yöntemlerini söyleyiniz.

1. Maske,
2. nazal kanül,
3. oksijen çadırı
4. mekanik ventilasyon,

5. nazofarengeal kateter

16) Nazofarengeal yolla oksijen uygulamada, çocuklar, kadınlar ve erkekler için kaç no'lu katater kullanılır.

Çocuklar için 8-10 F

, kadınlar için 10-12 Fr ve

erkekler için 2-14 Pr. no'lu kateter

17) Aspirasyon işleminde hangi aseptik teknik kullanılır? Kaç saniye sürer? Kaç defadan faza uygulanmaz?

Cerrahi aseptik teknik

10 saniye 3 defa

18) Aspirasyon uygulamalarında hastaya hangi pozisyon verilir?

Bilinci açık hastalarda;

orofarengeal aspirasyon için, başı bir tarafa dönük olacak şekilde semi-Fowler's

Nazofarengeal aspirasyon için boyun hiperekstansiyonda olacak şekilde semi-Fowler's pozisyonunda yatırınız.

Bilinci kapalı olan hastayı yüzü hemşireye dönük yan yatış pozisyonu

İLAÇ UYGULAMALARI

19) Bir defada 300mg Prednol ampul I.M. olarak istem edilmiştir. Elimizde 5ml. ile sulandırılarak verilen 250 mg. Lik ampuller bulunmaktadır. Hastaya bir defada kaç ml. Prednol verilmelidir?

5 ml 250

X 300 250xX= 5x300 X=6 ml.

20) Bir defada 1g. Ampisina Kapsül P.O. olarak istem edilmiştir. Elimizde 250mg. Ampisina kapsül bulunmaktadır. Hastaya bir defada kaç kapsül verilmelidir?

1gr.=1000mg.

375mg 1kapsül

750mg X

375xX=750x1 X=2

21) Dakika damla sayısı 10 olan IV sividan 3 saatte kaç ml sıvı verilmiş olur?

10 damla= X x 20 X= 90 ml.

22) Intravenöz infüzyon amacıyla ön kolda ve el sırtında kullanılan venler hangileridir? S

- Dorsal metakarpal venler,
- Bazilik ven,
- Sefalik ven,
- Radyal ven,
- Medyan kübital ven
- Aksesuar sefalik ven

23) Intravenöz sıvı tedavisinin komplikasyonlarından infiltrasyon nasıl gözlemlenir?

Intravenöz sıvı, vene giriş bölgesi etrafında subkütanöz boşluğa girdiği zaman kabarıklık, solgunluk, sıvı akış hızının azalması ya da yokluğu, ağrı ile ilgili değerlendirmeler yaparak gözlemleriz.

24) intramüsküler, subkutan, intravenöz, intradermal enjeksiyonlarda iğne numaraları ve iğne boyutlarını söyleyiniz.

Yol	Uygulama Yeri	İğne No	İğne Boyu	İğnenin Giriş Açısı	Verilen İlaç Miktarı
İntramüsküler (kas içi/IM)	*Dorsogluteal bölge (gluteus medius) *Ventrogluteal bölge (gluteus minimus) *Laterofemoral bölge (vastus lateralis, rektus femoris) *Deltoid bölge	20-23	2.5-3.75 cm	90 ⁰	1-3 ml
Intradermal/ intrakutan (Deri içi/ID)	*Önkol iç yüzü *Sırtın üst kısmı	26-27	0.6 –1 cm	5-15 ⁰	0,1-0,5 ml
Subkutan (derialtı/SC)	*Dış üst kol, *Üst bacağın (laterofemoral) ön yan kısmı, *Sırtta skapula altı *Dorsogluteal bölge *Karın (abdominal) bölgesi	25	1-1.5 cm	45-90 ⁰	0,5-1 ml
Intravenöz (ven içi/IV)	*Kolda: Bazilik, sefalik, median sefalik ven *Bacakta:sefanöz ven, popliteal, tibiali dorsalis pedis, marjinalis lateralis ven.	22-20 (Sıvı) 18-14 (Kan)	2,5-3,75 cm	30-45 ⁰ (deriye) 15 ⁰ (damara)	0,5-10 ml

25) Kan transfüzyonunda oluşabilecek reaksiyonlar nelerdir?

1. Hiperkalemi,Hipokalsemi
2. Dolaşım yüklenmesi
3. Enfeksiyon ajanlarının taşınması

4. Hemolitik Reaksiyon
5. Febril Reaksiyon (Titreme, Ateş)
6. Allerjik Reaksiyon

26) Hava kilidi tekniği neden uygulanır? Kaç ml hava?

0,2-0,3 ml; Kas içindeki ilacın üstüne verilen hava, ilacın cilt altı dokusuna dönüşünü engeller. Ayrıca iğnenin içinde kalan son ilacın da hava ile itilerek kasa verilmesini sağlar. Böylece iğne geri çekilirken az miktardaki bu ilaç cilt altına sızmamış olur.

27) Hastalarda enjeksiyon uygulamasına bağlı rahatsızlıkların en aza indirilmesi için, hemşire hangi uygulamaları yapmalıdır?

- -Uygun incelikte ve uzunlukta pürüzsüz ve keskin ucla löne kullanılmalıdır.
- -Hastaya kas gerginliğini azaltacak rahat pozisyon verilmelidir. Hastaya derin nefes almasını söylemek de gerginliği azaltır.
- Uygun bölge seçimi yapılmalıdır.
- -Enjektöre ilaç çektikten sonra, iğne ilaçla bulaşmış olacağından özellikle iritan ilaçlarda iğne mutlaka değiştirilmelidir
- -Çok duyarlı bireylerde, enjeksiyondan önce bölgeye 2 dk. süreyle buz ya da soğuk kompres uygulanabilir.
- İlacın doku içine yavaş verilmesi ağrıyı azaltan ve ilacın doku içine yayılımını ve emilimini kolaylaştıran bir yöntem olduğunda ilaç yavaş verilmeli.
- Enjeksiyon sırasında hastanın dikkatini başka yöne çekmek, bu sırada onunla konuşmak da gerilimi ve ağrının algılanmasını azaltan önlemlerdir,
- Çok miktarda ilaç ağrıyı başlatabilir. Bu nedenle her bölgeye yapılabilecek ilaç miktarının bilinmesi gerekir. 1.Move S. enjeksiyonlarda iğne çabuk ve düzgün bir şekilde batırılmalıdır.
- İğne dokunun içindeyken enjektör kımıldatılmadan, sabit tutulmalıdır. Aksi halde iğne, doku içinde hareket ederek daha fazla doku yıkımına yol açar.
- -Sakıncası yoksa enjeksiyondan sonra bölgenin dairesel biçimde hafifce ovulması, ilacın dokular arasında dağılımını artırır ve emilimini kolaylaştırır.

28) Narkotik ilaçlar nasıl saklanır? Narkotik ilaçlar kullanıldığında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Narkotik ilaçlar çift kilitli dolaplarda saklanmalıdır. Bunlar kullanıldığında, kesinlikle rapor tutmak gerekir. Bu rapora hastanın adı, narkotik ilacın miktarı, istemi veren hekimin adı, uygulayan hemşirenin adı, tarih ve saat kaydedilir. Narkotiğin ampul içinde artan bir dozu varsa, bunun da yok edildiğini belirtir bir not düşülür. Bu işlemi gözleyen bir hemşirenin de tanık olarak imza atması uygun olur. Hemşireler nöbet değişimleri sırasında narkotik ilaçları kesinlikle sayarak teslim alıp teslim vermelidirler. Sayımda bir eksiklik görülürse derhal bildirilmelidir

29) Parenteral ilaç uygulamaları hangi durumlarda tercih edilir?

- 1) İlaçların çabuk etki göstermesi istendiğinde,
- 2) Hasta oral yolla ilaç alamadığında

- 3) ilacın başka veriliş formunun olmadığı durumlarda
- 4) ilacın, oral yolla alındığında sindirim sisteminde etkisiz hale geldiği durumlarda,
- 5) Bilinçsiz hastalarda tercih edilir.

30) Buruna ilaç uygularken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

- 1) İşlemden önce hastaya kağıt mendil verilmelidir.
- 2) Hasta oturuyorsa başını arkaya doğru iyice eğmesi söylenir.
- 3) Eğer hasta yatıyorsa başı yastık üzerinden geriye doğru kaydırılır. Bu pozisyon, ilaç damlalarının burun deliklerine iyice yayılmasını sağlar.
- 4) Damlalığa her iki burun deliğine yetecek kadar ilaç çekilmeli ve artan ilaç, ilaç şişesine boşaltılmamalıdır.
- 5) Hemşire burnun ucunu başparmağıyla yukarı kaldırmalı ve diğer elindeki damlalığın ucunu, burun deliğinin içine 0.6 cm kadar sokmalıdır.
- 6) İlaç sırasıyla her iki burun deliğine de damlatılmalıdır. Damlalığın ucu burun mukozasına değdirilmemelidir. Bu durum hastanın hapşırmasına neden olacağı gibi mukozayı da zedeleyebilir.
- 7) İlacın dışarı akmaması için hasta bir kaç dakika pozisyonunu korumalıdır. Hastalar genellikle, orofarenksten ağızlarına gelen ilacı tükürmek isterler.

31) Kulağa ilaç damlatılırken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

1. Hastayı rahatsız etmemesi için kulağa damlatılacak ilacın ilik olması gerekir. Eğer varsa, normal salin ile ıslatılmış pamuk tamponla bölge temizlenmelidir.
 2. Pozisyon vermek için hastaya sağlam kulağı üzerine yatması söylenmelidir. Eğer hasta oturuyorsa, başını sağlam kulağının olduğu yöne iyice eğmelidir.
 3. Damlalığa yeteri kadar ilaç çekilmeli; artan ilaç, ilaç şişesine tekrar boşaltılmamalıdır.
 4. Kulak kepçesi, aşağıda önerilen biçimde çekildiğinde dış kulak yolu düzleşecek, damlatılan ilaç kolayca kanal içine yayılarak kulak zarına ulaşacaktır. Yetişkin bireyde kulak kepçesinin kıkırdak kısmı yukarı ve geriye doğru, üç yaşına kadar olan çocuklar ve bebeklerde ise aşağı ve geriye doğru çekilmelidir.
 5. Damla, doğrudan doğruya timpan zar üzerine değil, dış kulak yolunun çeperine damlatılmalıdır. Aksi halde hastaya rahatsızlık verir.
 6. Damla damlatılırken damlalığın ucu, kulak kepçesine ya da kulak yoluna değdirilmemeli, doku zedelenmemelidir
 7. Damla damlatıldıktan sonra kulak kepçesi bırakılmalı ve ilacın dışarı akmaması için hastaya bir süre sonra pozisyonunu koruması söylenmelidir.
- İlacın dış kulak yolu içinde timpan zarına doğru hareket etmesini kolaylaştırmak için, tragus (dış kulak yolu ağzındaki kıkırdaksı çıkıntı) üzerine bir kaç defa nazikçe bastırılmalıdır.
9. Eğer gerekiyorsa, dış kulak yoluna gevşek bir pamuk tampon yerleştirilir. Basınç yapacağından ve dışarıya doğru olan akıntıyı engelleyeceğinden, sıkı tamponlar kullanılmamalıdır. 30 dakika sonra

tampon kulaktan çıkarılmalıdır. Eğer diğer kulağa da ilaç damlatmak gerekiyorsa, 5 dakika beklenmelidir.

32) Ventrogluteal bölge tespitini anlatınız.

- Enjeksiyon bölgesinin saptanması için hemşire hastanın sağ kalçasında sol elini, sol kalçasında sağ elini kullanmalıdır.
- El ayasının alt kısmı büyük trokantere yerleştirilir
- Baş parmak hastanın kaşığını gösterirken diğer dört parmak hastanın başını gösterir.
- İşaret parmağı anterior superior ilyak spinaya yerleştirilir.
- Orta parmak mümkün olduğu kadar arkaya doğru açılır ve ilyak kristaya dokunur. Böylece işaret, orta parmak ve ilyak kristayla sınırlı bir üçgen alan oluşturulur

33) Z tekniği ile enjeksiyon uygulamasının sebebi nelerdir.

Deri altı dokusu için aşırı derecede tahriş edici olan ve /veya deri altını kalıcı şekilde boyayan demir gibi ilaçların intramüsküler enjeksiyonunda kullanılır.

34) intradermal enjeksiyon uygulaması için sıklıkla kullanılan bölgeleri söyleyiniz.

ön kolun iç yüzü, üst kolun arka yüzü, sırtın üst yüzü ve üst göğüs bölgesidir.

35) Intravenöz sıvı tedavisinin komplikasyonlarını söyleyiniz.

- İnfiltrasyon,
- flebit,
- dolaşım yüklenmesi,
- emboli,
- kanama
- enfeksiyondur.
-

36) Kan transfüzyonu sırasında hemolitik reaksiyon gerçekleşirse hemşirenin yapması gereken uygulamalar

- Kan transfüzyonu derhal durdurulur,
- %0.9'luk NaCl solüsyonu takılır,
- damar yolu açılır,
- Hekime haber verilir,
- Her 10-15 dakikada yaşam bulguları ölçülür ve şok yönünden değerlendirilir,
- mesane kateterizasyonu uygulanır ve aldığı çıkardığı sıvı saatlik olarak ölçülür,
- Oksijen verilir,
- Vazopressör ilaçlar ve epinefrin hekim istemine göre verilir.

37) Parenteral ilaç uygulamalarında 4 temel enjeksiyon tipi nelerdir?

1. Intramüsküler enjeksiyon
2. Subkutan enjeksiyon,
3. Intrakutan/intradermal enjeksiyon,
4. intravenöz enjeksiyon

38) Deri aplikasyonunda dikkat edilmesi gereken durumlar nelerdir?

- Deri kuru ve temiz olmalıdır. Daha önce sürülmüş ilaçlar temizlenmelidir.
- Temizlik işlemi sabun ve suyla yapılmalıdır. Böylece yağ bezlerinin gözenekleri açılarak emilim kolaylaştırılmış olur. Gerekirse yerel sıcak uygulama yapılabilir. Böylece kan dolaşımı artacağından emilim hızlanır.
- Losyonlar, süspansiyon özellikte oldukları için kullanılmadan önce çalkalanmalı ve bir parça gaz beziyle deriye uygulanmalıdır.
- Krem ve merhemler ovularak deriye yedirilmelidir. Ovma önerilmiyorsa, yumuşak bir hareketle ilaç deri Üzerine yayılmalıdır.
- İlaç vücudun sırt gibi geniş bir bölgesine sürülecekse, hastanın ürpermemesi için avuç içinde bir süre ısıtılmalıdır.
- İlaç pudra şeklinde ise, hastanın bunu solumamasına dikkat edilmelidir.
- İlaç maddesi, hiç bir zaman gerektiğinden fazla kullanılmamalıdır.
- Bazı ilaçlar, ilacı uygulayanın da elinden kolayca emilebilir özellikte olabilir. Bu durumda hemşire eldiven giymelidir. Yine hastanın rahatsızlığı bulaşıcı ise, eldiven kullanılmalıdır. Bunların dışında da eldiven kullanarak hiçbir deri lezyonuyla doğrudan doğruya temas etmemek, enfeksiyonları önlemek açısından önemlidir.

39) ilaç uygulamalarında 8 doğru ilkeyi söyleyiniz.

1. Doğru ilaç
2. Doğru doz
3. Doğru hasta
4. Doğru zaman
5. Doğru yol
6. Doğru ilaç şekli
7. Doğru kayıt
8. Doğru yanıt
- 9) Reddi kabul
- 10)Hasta eğitimi

40) %10'luk povidon-iyot solüsyonundan 500 ml %2'lik povidon-iyot solüsyonu hazırlamak için kaç ml povidon-iyot solüsyonu kaç ml distile su gereklidir?

LIN IM?

$$C1 \times V1 = C2 \times V2 \quad 500 \times \%2 = \%10 \times x$$

X=100 ml. Povidon iyot 400 ml. Distile Su

41) 600 ml sivinin 8 saatte verilebilmesi için dakika damla sayısını hesaplayınız.

42) Kan transfüzyon öncesinde neler kontrol edilmelidir? Açıklayınız.

- -Donörün kan grubu,
- -Donörün Rh faktörü,
- -Kanın alındığı tarih,
- -Alıcının adı,
- -Alıcının kan grubu,
- -Alıcının Rh faktörü
- -Cross-match yapıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.

43) Subkutan enjeksiyon bölgelerini söyleyiniz.

- Üst kolların dış yüzü
- kostal hattın altındaki ilyak kristalara kadar olan karın bölgesi,
- uyluğun ön yüzü, sırtın üst kısmı
- arka kalça bölgesi

44) Intramüsküler enjeksiyon bölgelerini söyleyiniz.

- Dorsogluteal,
- Ventrogluteal,
- Rektus femoris,
- Vastus lateralis,
- Delotiod,
- Triseps

45) Intramüsküler, subkutan, intradermal enjeksiyonlarda verilebilecek ilaç miktarlarını söyleyiniz.

Intramüsküler * 1-3 ml
Intradermal *0,1-0,5 ml
Subkutan *0,5-1 ml

46) Intramüsküler enjeksiyon amacıyla kullanılan dorsogluteal bölgenin tespiti nasıl belirlenir? posteriyor superiyor ilyak spina ile femurun büyük trokenterini birleştiren hayali çapraz çizginin bölgedir.

47) Intramüsküler enjeksiyonun komplikasyonları nelerdir?

1. ilacın yanlılıkla damara verilmesi,
2. apse,
3. nekroz,
4. derinin dökülmesi,
5. sinir yaralanmaları,

6. uzun süreli ağrı ve

7. periostit

48) Kan transfüzyonuna bağlı reaksiyon geliştiğinde ne yapılır?

Kan akışı durdurulur, kan seti çıkarılarak sıvı seti takılır, %0.9'luk NaCl solüsyonu gönderilerek damar yolunun açıklığı sağlanır, Hemen hekime haber verilir.

SİNDİRİM SİSTEMİ UYGULAMALARI

49) Hastanede hastaların beslenmesini olumsuz etkileyen etmenler nelerdir?

- iştahsızlık
- Huzursuzluk
- İlaçlar
- Tetkik için aç bekleme
- Ortam ve yemek zamanlarındaki değişiklikler
- Hastane yemeklerine ve diyetle uyum sağlayamama
- Besin tüketiminin takibinin iyi yapılmaması

50) Hastanın beslenme gereksinimlerini karşılama yolları nelerdir?

- Ağız yolu /Oral yol,
- Enteral beslenme,
 - Nazogastrik yol-
 - Nazoduodenal yol-
 - Nazojejunal yol –
 - Gastrostomi yoluyla
 - Jejunostomi yoluyla,
- Parenteral yol

51) Enteral beslenme nedir?

Sindirim sistemi işlevleri olan ancak oral yoldan beslenemeyen hastalarda besinlerin bir tüp aracılığı ile doğrudan mide, duodenum veya jejunuma verilmesidir.

52) Enteral beslenme endikasyonları nelerdir?

- Yarı bilinçli ya da bilinçsiz hastalar
- Felçli hastalar
- Ağız, yüz yaralanması ya da ameliyatı olan hastalar
- Çiğneme ve yutma problemi olan hastalar
- Emme ve yutma refleksi olmayan prematüre bebekler
- Anoreksiya nevrozalı hastalar
- Özofagus hastalıkları (kanserler, yaralanma vb)
- Sindirim sistemi hastalıkları (pankreatit vb)
- Organ yetmezlikleri (karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği)
- Ameliyat öncesi hazırlık
- Ameliyat sonrası beslenme

53) Enteral beslenmenin avantajları nelerdir?

- Barsak işlevlerinin kısa sürede normale dönmesine yardımcı olur
- Enfeksiyon riskinin düşük olması ve gereksinimleri karşılaması açısından total parenteral (damar yoluyla) beslenmeden daha güvenlidir.
- Fizyolojiye uygundur.
- Uygulanması kolaydır
- Total parenteral beslenmeye göre ucuzdur
- Metabolik ve septik komplikasyon görülme oranı düşüktür
- Az personelle uygulanır

54) Mide intübasyonu ne demektir?

Mideye burun, ağız ya da gastrostomi açıklığı yolu ile tüp yerleştirilmesine "mide intübasyonu (gastrik entübasyon)" denir.

55) Nazogastrik veya orogastrik tüp uygulaması'nda tüpü yutturmadan önce tüpün ne kadarının ilerletileceğini belirlemek için ölçüm nasıl yapılır?

- Nazogastrik tüpü: hastanın burun ucundan kulak memesine oradan ksifoidin alt ucuna kadar uzatınız (55-65 cm). Ksifoidin alt ucuna gelen noktayı kalem veya flasterle işaretleyiniz.
- Orogastrik yolla: uygulayacaksanız tüpün ucunu hastanın dudaklarının dikey orta hattı üzerine yerleştiriniz, buradan kulak memesine, daha sonra da sternumun ksifoid çıkıntısına kadar uzatıp kalem veya flaster ile işaretleyiniz.

56) Nazogastrik veya orogastrik tüp uygulaması'nda hangi bulgular tüpün trakeaya girdiğini gösterir.

Öksürme, Konuşamama, Boğulma Hissi, Siyanoz, Dispne

57) Nazogastrik veya orogastrik tüp uygulaması'nda tüpün doğru yerde olup olmadığını belirlemede kullanılan yöntemler nelerdir? Açıklayınız.

- Enjektörle mideye verilen hava sesini stetoskopla dinleme
- Mide sıvısının pH ve renginin değerlendirilmesi
- Röntgen

58) Nazogastrik veya orogastrik tüp uygulaması'nda beslenme tüpünün yeri hangi durumlarda kontrol edilmelidir.

Tüp ilk yerleştirildiğinde, her aralıklı beslemeye başlamadan önce, sürekli beslenmeler sırasında

59) Nazogastrik veya orogastrik tüp yolu ile besleme hangi yöntemlerle yapılır. Bunlar nelerdir? Sürekli, aralıklı beslenme

60) Nazogastrik veya orogastrik tüp yolu ile aralıklı besleme kaç şekilde yapılır. Bunlar nelerdir? huni/enjektör, damla düzeni beslenme seti

61) Nazogastrik veya orogastrik tüple beslenen hastalarda gelişebilecek komplikasyonlar nelerdir?

Pnömoni, Bulantı - Kusma, Diyare ve Abdominal Kramplar, Konstipasyon, Dehidratasyon, Glikozüri ve sık idrar yapma

62) Nazogastrik veya orogastrik tüp yolu ile ilaç verirken uyulması gereken ilkeler nelerdir?

- Mümkünse ilacın sıvı formu kullanılmalı,
- Sıvı ilaç bile olsa verilmeden önce su ile dilüe edilmeli,
- Tablet veya kapsül formunda ise kapsülün açılıp açılmayacağı tabletin ezilip ezilmeyeceğinden emin olunuz.
- Ezilen tabletler veya açılan kapsüller oda ısısındaki suda eritilmelidir.
- İlaçları vermeden önce ve verdikten sonra sonda yoluyla su verilmelidir.
- Birden fazla ilaç verilecekse birbirine karıştırılmamalı her ilaç ayrı verilmeli ve her ilaç ayrı verilmelidir. Amaç ilaç etkileşimini önlemektir.
- İlaçların önerilen kullanılış şekline (aç/tok) dikkat ediniz.
- İlaçları hekime danışmadan kesinlikle beslenme solüsyonlarının içine karıştırmayınız

63) Nazogastrik tüpün uzun süre kalmasına bağlı gelişen komplikasyonlar nelerdir?

- Hastanın burun delikleri çevresindeki deride erezyon,
- Sinüzit,
- parotitis (tükürük bezi iltihabı),
- özofajit (özofagus mukozasının iltihabı),
- özofagotrakeal fistül (özofagus ile trakea arasında bir açıklığın oluşması),
- mide ülseri,
- ağız ve akciğer enfeksiyonları,
- Sivi elektrot dengesizliği.

64) Total parenteral beslenme nedir?

Sindirim sistemi işlevleri yetersiz olan hastalarda venöz yolla uygulanan beslenme desteğidir.

65) Rektal tüp nedir? Ne işe yarar?

Rektal tüp, genellikle kauçuk veya plastikten yapılmış, içinde solüsyon veya gazın geçeceği bir-iki deliği olan tüptür. Rektal tüp, peristaltizmi uyarır, anal sfinkteri açık tutarak gazın çıkması için bir yol oluşturur ve doğal yolla çıkarılamayan karındaki gazın çıkarılmasını sağlar.

66) Lavman nedir? Ne için yapılır?

Lavman, rektum ve sigmoid kolona solüsyon verilmesidir. Lavmanlar konstipasyonu gidermek, muayeneye, radyolojik tetkiklere ve cerrahi girişimlere hazırlamak, bağırsak mukozasında yerel veya sistemik etki gösteren ilaçlar vermek amacı ile uygulanırlar

bireyi

67) Lavman çeşitleri nelerdir?

- Temizleyici Lavman
- Yağ-Retansiyon Lavmanı,

- Gaz çıkarıcı Lavman,
- Tedavi edici Lavman

68) Temizleyici lavman nedir? Hangi amaç için uygulanır?

- Konstipasyonu ve fekal impakşın gidermek,
- X-ray incelemeleri,
- endoskopi,
- cerrahi girişimler veya doğuma hazırlık için bağırsakları boşaltmak.
- Bağırsak jimnastiği programı başlatmak için bağırsakları boşaltmak

69) Temizleyici lavman solüsyonları nelerdir?

Musluk Suyu, Normal Tuz Solüsyonu, Hipertonik Solüsyonlar, Sabun Solüsyonu

70) Nazogastrik tüple beslenen hastalarda bulantı-kusma nedenlerini söyleyiniz.

- Tüpün yerleştirilmesinden hemen sonra beslenmeye geçme
- Tüpün uygun yerde olmaması,
- Hızlı beslenme,
- Fazla miktarda besin verilmesi,
- Beslerken uygun pozisyon verilmemesi.

71) Rektal tüpün erişkinler için numaraları nedir?

24-34 Fr.

72) Erişkin hastaya lavman uygularken rektal tüpün kaç cm'lik kısmı rektuma itilir, kaç dakikadan fazla uygulanmaz?

10 cm-20dk

73) Nazogastrik tüp ile beslenen hastalarda neden glikozüri görülür? Açıklayınız.

Verilen besininde karbonhidrat oranının fazla olmasına bağlı kan glikoz düzeyi yükseldiğinde glikozüri ve sık idrara çıkma görülür.

74) Nazogastrik kateteri olan hastada hemşirelik bakım uygulamaları nelerdir?

Ağız bakımı yapılması gerekir. Bunun için:

- Dişler ve dil fırçalanır.
- Dişetlerine masaj yapılarak kan dolaşımı uyarılır.
- Dişlerini fırçalayamıyorsa gargara ile ağız bakımı verilir.(%1 Sodyum bikorbanatlı solüsyonu, serum fizyolojik).
- Dudaklarına vazelin sürülür.
- Buruna tüpü tespit eden flasterler temiz ve kuru olmalıdır. Bu nedenle çok terleyen hastaların flasterleri her gün değiştirilir. Flasteri kaldırınca cildi sabunlu bez ile nazik bir şekilde silip iyice kurulayınız. Yeni flaster yapıştırırken yerini olabildiğince değiştiriniz. Tüpe zarar verebileceği için krem ya da pudra kullanmayınız.

- Burun bakımı verilir. Burundaki kurumuş sekresyonlar temizlenir.
- Tüpün açıklığını sürdürmek veya tıkanıklığı açmak için irigasyon işlemi uygulanır.

75) Temizleyici lavmanda sıklıkla kullanılan musluk suyunun etki mekanizması nedir?

Musluk suyunun osmotik basıncı, interstisiyel boşluklardaki sıvılardan daha düşüktür. Su, iki tarafın basıncını eşitlemek için bir zar yoluyla, az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçer. Böylece su, bağırsaklardan interstisiyel boşluğa geçer. Bu nedenle musluk suyu lavmanı, böbrek işlevleri bozuk veya kalp hastalığı olan hastalar için güvenilir değildir.

YATAK BAŞI HASTA BAKIMI

76)Ağız sağlığı ile ilgili sorun gelişme riski taşıyan hastalar kimlerdir?

1. Genel durumu bozuk olan hastalar
2. Ust ekstremitelerinde hareket kısıtlılığı olan hastalar (felçli, alçılı vd hastalar)
3. Ağız yoluyla beslenemeyen hastalar
4. Sıvı kısıtlaması uygulanan hastalar
5. Nazogastrik sondası bulunan hastalar
6. Ağızdan solunum yapan ya da oksijen tedavisi uygulanan hastalar
7. Ağız ve çene ameliyatı geçirmiş olan hastalar

77)Ağız bakımında kullanılan solüsyonların/gargaraların isimleri nelerdir?

1. Hidrojen Peroksid-
2. Normal salin solüsyonu
3. Sodyum bikarbonat solüsyonu
4. Gliserin-limon karışımı

78)Sırt masajı yapılmaması gereken durumlar nelerdir?

- Kaburga ya da omurlarında kırık olan hastalar,
- Sırtında yanık olan hastalar,
- Açık yarası olan hastalar,
- Tromboflebit, Miyokard enfarktüsü geçiren hastalar

79)Masaj sırasında kullanılabilecek yöntemleri söyleyiniz.

Efloraj, Petrisaj, Tapotman, Friksiyon, Vibrasyon, Haşur

Efloraj: Vücudun geniş alanlarına avuç içi ile, venöz dolaşımın kalbe dönüş yönüne doğru yapılan yumuşak, sıvazlama şeklindeki hareketlerdir. Bu manevra el, ayak gibi bölgelere aşağıdan yukarıya doğru yavaş, ritmik, uzun hareketlerle geriye ise yavaş yavaş ve hafif hareketlerle uygulanır. Avuç içinin hasta derisi ile sıkıca teması gerekir. Masajın hangi güçle yapılacağı, istenen etki adale miktarı ve tonüsüne göre değişir. Sırtta uygulamada iki el birlikte kullanılmalıdır. Ekstremitelerde ise bir elle masaj yapılırken diğer elle alttan desteklenmelidir.

Petrisaj: Subkutan doku ve kaslara yapılan yoğurma hareketidir. Genellikle geniş kaslara uygulanır. Hareket, adelenin doğrultusunda, ritmik, kısa, sıkıştırıcı, bükücü ve basınç yapıcı işlemler dizisidir.

Bütün el deri ile temas etmekle birlikte, güç baş ve distal parmaklardadır. Sırta uygulandığında her iki el birlikte kullanılır. Eksremiteelerde ise bir elle uygulama yapılırken, diğer elle destek olunur. Amaca ve hastanın reaksiyonuna göre basınç uygulanır.

Tapotman: Avuç içini kubbeleştirerek, hafif vuruş biçiminde yapılan harekettir. Titreşim yolu ile derine etki eder. Zayıf hastalarda tercih edilmez. Sırt bölgesine uygulanan topatman manevrası sıklıkla uygulanan bir hareket değildir.

Friksiyon: Omurlarda ve omuz başlarında olduğu gibi, kemik çıkıntılarının etrafına, ilk iki parmakla yapılan manevradır. Küçük daireler çizerek yapılan titreşim hareketidir.

Vibrasyon: Parmak uçları ile yapılan titreşim hareketleridir.

Haşur: Elimizi bıçak sırtı gibi kullanarak vurma hareketleri şeklinde yapılır. Bir el uzaklaşırken diğer el onun yerini alacak şekilde periyodik olarak uygulanır.

80) Ağız bakımında kullanılan solüsyonlardan sodyum bikarbonat solüsyonu için yüzde kaç'lık formu kullanılır?

%1'lik Sodyum bikarbonat solüsyonu: 500cc Su+ 1 tatlı kaşığı (5g) NaHCO₃

81) Ağız bakımında uygulanan adımları sırasıyla söyleyiniz.

1. Yakın taraf üst çene: en arka dişten, çene orta hattına kadar
2. Uzak taraf üst çene: en arka dişten, çene orta hattına kadar
3. Önce uzak taraf sonra yakın taraf yanak mukozası
4. Dil üzeri ve altı
5. Uzak taraf alt çene: en arka dişten, çene orta hattına kadar
6. Yakın taraf alt çene: en arka dişten, çene orta hattına kadar
7. Damak

82) Kadın ve erkek hastalara uygulanan perine bakımının adımlarını söyleyiniz.

- Kadın hasta:
 - önce uzak sonra yakın taraf uyluk
 - mons pubis
 - labia majör
 - labia minör
 - üretral meatus
 - vajinal orifis
- erkek hasta:
 - önce uzak sonra yakın taraf uyluk
 - mons pubis
 - glans penis
 - skrotum

YATAGA BAĞIMLI HASTA BAKIMI

83) Bası yarasının evrelerini söyleyiniz

Şüpheli derin doku yaralanması: Bütünlüğü bozulmamış ciltte lokalize morluk veya renk değişikliğinin olması veya alttaki dokunun basınç veya sürtünme nedeni ile hasarlanması sonucu ciltte bol mas şüpheli derin doku yaralanması tanımını almaktadır.

1. I. evre basınç ülseri: Sağlam deride genellikle de kemik çıkıntılar üzerinde solmayan eritem vardır. Koyu pigmentasyonlu deride beyazlaşma görülmeyebilir, ancak rengi çevreleyen deriden farklıdır.
2. II. evre basınç ülseri: Dermisin kısmi kalınlıkta kaybı olup, yara yatağının pembe kırmızı olduğu, ölü dokunun olmadığı yüzeysel bir ülser şeklinde tanımlanmıştır
3. III. evre basınç ülseri: Bu evrede tam kalınlıkta doku kaybı oluşmuştur. Ciltaltı yağ dokusu görülebilir, ancak doku kaybı kemik, tendon ya da kasa ulaşmamıştır. Yara kabuğu olabilir, fakat bu kabuk doku kaybının derinliğini gizlemez. Bu evrede sinüs ya da tüneller görülebilir.
4. IV. evre basınç ülseri: Kemik, tendon ve kasları da içine alan tam kalınlıkta doku kaybı olarak tanımlanmıştır. Yara yatağının bazı yerlerinde kabuk ya da eskar görülebilir. Bu evrede çoğu zaman tünel ya da sinüsler oluşmuştur.
5. Evrelendirilemeyen basınç ülseri: Yara yatağının ölü doku (sarımsı kahverengi, kahverengi ya da siyah) veya kabukla (sarı, sarımsı kahverengi, gri, yeşil ya da kahverengi) kaplanmış olması nedeni ile değerlendirilemeyen, tam kat doku kaybının olduğu yaralar evrelendirilemeyen basınç ülseri olarak tanımlanmıştır

84)Yatak istirahatindeki hastalarda yeterli sıvı alımı neden önemlidir?

- Trombüs oluşumunu önler (kan viskozitesini azaltır)
- Solunum yollarından sekresyonların atılımını kolaylaştırır
- Konstipasyonu önler
- idrar yolu enfeksiyonunu önler
- Bası yaralarını önler

85) Bası yarasına neden olan içsel etmenler nelerdir?

- Yaşlılık
- Beslenme Bozukluğu
- Kan Basıncı Vücut Isısı
- Duyu Kaybı ve Hareketsizlik
- Psikolojik Etmenler

86)Basınç yarasına neden olan dışsal faktörler nelerdir?

- Bası
- Sürtünme (Friksiyon)
- Yırtılma (Shear)
- Nemlilik

87) Yatak istirahatının dolaşım sistemi üzerindeki zararlı etkileri nelerdir?

- Ortostatik Hipotansiyon,

- Trombüs-Pulmoner Emboli-Tromboflebit
- Valsalva Manevrasının Kullanımında Artma,
- Kalp Yükünde Artma

88) Yatağa bağımlı hastalarda trombüs oluşumunun önlenmesine yönelik hemşirelik bakımını açıklayınız.

- Hasta yatak içinde olabildiğince hareketli tutulmalı, günde üç kez eklemlerin normalde yaptıkları tüm hareketler (ROM egzersizleri) yaptırılmalıdır (aktif ya da pasif hareketler).
- Hasta en erken dönemde ayağa kaldırılır.
- Kan viskozitesini azaltmak için yeterli sıvı alımı sağlanmalıdır.
- Yatak içinde elastik çorap ve bandaj uygulanarak venöz dönüş arttırılır.
- Popliteal boşluğa basınç yaptığı için hastanın diz altları yastıkla desteklenmemelidir.
- Hastanın bacak bacak üstüne atarak oturması, sandalye kenarının diz arkasına basınç yapması önlenmelidir. Bunun için sandalyede otururken hastanın bacakları yükseltilmelidir
- Hasta yatak veya sandalyede otururken bacak kaslarını kasmaı söylenerek venöz dönüşün uyarılması sağlanmalıdır
- Trombüsün yerinden koparak emboliye neden olmaması için bacaklara masaj yapılmamalıdır.

89)Yatak istirahatindeki hastalarda valsalva manevrasının kullanımını azaltmaya yönelik hemşirelik bakımını açıklayınız.

- Konstipasyon önlenmelidir.
- Hastaya ikinmaktan kaçınması gerektiği öğretilir.
- Sürgü verirken hastanın kalçası desteklenerek kaldırılmalıdır.
- Sakıncası yoksa hastanın sürgü yerine oturakli sandalye kullanmasına izin verilir.
- Kalp hastalarına yatak içinde hareket ederken yardım edilmeli ve gerektiğinde sağlık personelinen yardım istemeleri söylenmelidir.

90)Yatak istirahatinin solunum sistemine ilişkin zararlı etkileri önlemeye yönelik hemşirelik bakımını açıklayınız.

- Hastanın pozisyonu sık sık değiştirilir (Gündüz 2,gece 4 saat ara ile).
- Solunum ve öksürme egzersizleri yaptırılır.
- Yeterli sıvı alması sağlanır (Günde iki litre).
- Ateş, öksürük, göğüs ağrısı, yeşil balgam, kikositoz gibi hipostatik pnömoni belirtileri gözlenir.

91)Yatak istirahatinin üriner sisteme ilişkin zararlı etkilerinden biri olan idrar yapma gücünü gidermeye yönelik hemşirelik bakımını açıklayınız,

- Hastanın elleri ılık suda bekletilir. Hastanın perinesine ılık su dökülür.
- idrar yapma refleksini uyarmak için uylukların iç yüzüne hafifçe vurulur veya buz uygulanır.
- Hastanın karnının alt kısmına sıcak uygulama yapılır.
- Hasta ılık su dolu küvete oturtulur..
- Hasta tüm uğraşlara rağmen idrarını yatarak yapamıyorsa; erkek hastaların yatağın yanında ayakta,

kadın hastaların sürgüye oturarak idrar yapmalarına izin verilir.

92)Yatak istirahatine bağlı gelişen üriner sisteme ilişkin zararlı etkiler nelerdir?

İdrar Yapma Güçlüğü, Böbrek Taşı Oluşumu

93)Yatak istirahatinin kas-iskelet sistemi üzerindeki zararlı etkilerini önlemeye yönelik hemşirelik bakımını açıklayınız.

- Hastanın pozisyonu sık sık değiştirilmelidir. Hareketsizlik sonucu kasların kemikler üzerinde meydana getirdiği gerginliğin kalkması kemiklerden kalsiyum mobilizasyonuna neden olur.
- Yatak sert ve düz olmalıdır.
- Masaj yapılmalıdır.
- ROM (Range of Motion) egzersizleri adı verilen egzersizler günde üç kez ve her egzersiz beş kez olmak üzere yapılmalıdır. (ROM eklemlerin yapabileceği tüm hareketlerdir).
- Kaslar için izometrik egzersizler özellikle yapılmalıdır (izometrik egzersizler, kasların uzunluğu değişmeden gözle görünür bir hareket olmaksızın yaptırılan egzersizlerdir).
- Ayak düşmesini (planter fleksiyon) önlemek için ayak tahtası kullanılmalıdır. Ayaklar üzerinde basıncı önlemek için üst yatak takımları gergin olmayacak şekilde hazırlanmalıdır.
- Ayak, bacak ve kalçanın eksternal rotasyon kontraktürünü önlemek için ayak, bacak ve kalça rulo çarşaf, kum torbaları ile desteklenmelidir.

94)Yatağa bağımlı hastalarda konstipasyon ve fekal impakşın gelişmesini önlemeye ve tedaviye yönelik hemşirelik bakımını açıklayınız

- Hastanın defekasyon sıklığı, gaita miktarı, kıvamı izlenir ve kaydedilir.
- Hergün belirli saatlerde sürgü verilir.
- Dışkılamayı kolaylaştırmak için hasta oturur pozisyona getirilir. Bunun için yatağın başı yükseltilir, hastanın sırtı yastıkla desteklenir.
- Sabahları aç karnına su, kayısı/erik kompostosu içmesi sağlanır.
- Hasta için sakıncası yoksa günlük sıvı miktarı arttırılır (2lt.).
- Konstipasyon önlenemezse doktor istemine göre laksatifler, gliserinli suppozituar uygulanır
- Bu uygulamalar etkili olmazsa boşaltıcı lavman uygulanır.
- Fekal impakşın gelişmişse hekim tarafından çıkarılması gerekir.

95) Yatak istirahatinin mental durumla ilgili duyuşsal uyarıyı arttırmak için gerekli olan hemşirelik bakımını açıklayınız.

- Bireye kendi kendini uyarma yöntemleri (hesap yapma, şarkı söyleme, ezbere şiir okuma vb.) öğretilir.
- Görsel uyarı sağlamak için; renkli çarşaf, pijamalar, saatler, takvim, resim kullanılır. İştme uyarıları sağlanır (isim ile seslenme, radyo dinleme, TV izleme, bireye bir şeyler okuma).
- Tat ve koklama uyarıları sağlanır (ağız ve diş bakımı yapılır, farklı yemekler sunulur, yiyecekleri yemeden önce koklaması sağlanır).
- Dokunsal uyarılar sağlanır (sırt masajı uygulanır, egzersizler yaptırılır, dokunma kullanılır). Bilişsel uyarılar sağlanır.(kendi bakımına katılması sağlanır, belirli olayları, bireyin işi ve hobileri tartışılır).

- Emosyonel uyarılar sağlamak için hasta korkularını düşünce ve algılarını paylaşması için desteklenir. Hallüsinasyonu olan hasta ile tartışmadan gerçeğe yöneltilir.

96) Bası yaralarının en sık görüldüğü bölgeleri söyleyiniz.

- Sakral bölge,
- Koksiks bölgesi,
- Iskeal tuberositler,
- Büyük torakanterler,
- Topuklar, Skapulalar
- Başın arkası,
- Dirsekler, Dış malleoller

97) Bası yaralarını önlemeye yönelik hemşirelik girişimlerinden 5 tanesini söyleyiniz

- Derinin gözlenmesi bası yarası oluşumunu önlemeye yönelik girişimlerin planlanması ve yapılan girişimlerin sonuçlarını değerlendirilmesi gerekir. (Bası yarası oluşma riski tanımlama ölçeklerinin kullanılması, Deri Tolerans Testinin uygulanması)
- Yatağa bağımlı hastalarda gündüzleri iki saat, gece dört saat aralıklarla pozisyon değiştirilmelidir.
- Hasta tekerlekli sandalyeye bağımlı ise 30 dakikada bir 60 saniye süresince elleri ile destek olarak, sandalye üzerinde kalçalarını yükseltmesi sağlanmalıdır.
- Hastanın genel durumu uygunsa belirli aralıklarla yataktan sandalyeye alınıp 30dk, oturması sağlanmalıdır.
- Sürgü verirken ya da alırken sürtünmeyi önlemek için hastanın kalçası desteklenerek kaldırılmalıdır.
- Hastanın hareket yeteneği ve gücü varsa yürümeye teşvik edilmeli, eklemlerde kontraktür oluşmaması için 8 saatte bir ROM (range of motion) egzersizleri yaptırılmalıdır.
- Hastanın pozisyonu değiştirilirken sürtünmeyi önlemek için kaldırılarak döndürülmelidir.
- Hastanın dolaşımını uyarmak için günde 1-2 kez masaj yapılmalıdır. Masaj yaparken kurutucu etkisi nedeni ile
- pudra ve alkol kullanılmamalıdır. Nemlendirici kremler, vazelin tercih edilmelidir.
- Hasta yeterli sıvı alması için desteklenmeli, sakıncası (Kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği vb) yoksa günde 2 lt Sıvı alması sağlanmalıdır.
- Dengeli ve yeterli beslenme sağlanmalıdır. Yemek yerken hastaya rahat bir pozisyon verilmeli, kendi kendine yiyemeyenlere yardım edilmeli, temiz ve güzel bir ortam sağlanmalıdır.
- Deri kuru ve temiz tutulmalıdır. Temizlik cilt sağlığını destekler. Banyo dolaşımı uyarır, kas ve eklem hareketi sağlar, hastayı rahatlatır.
- Ciltteki kuruluk ve çatlakları önlemek için nemlendirici/yağlayıcı krem ve losyonlar kullanılmalıdır (Vazelin, Bepanthen vb.).
- Derinin havalanmasını sağlayan pamuklu/keten yatak takımları ve giysiler kullanılmalı, ısı ve neme neden olan sentetik kumaşlar kullanılmamalıdır.
- Hemşire inkontinanslı hastaya mesane eğitimi yapılmalıdır. .
- Basınç noktalarını değiştirdiği için havalı yatak, su yatağı kullanılabilir.

- Koyun postu, vücut ısını normal düzeyde tuttuđu, sürtünmeyi ve basıncı azalttığı için bası yaralarının önlenmesinde kullanılır
- Kızarık bölgelere 4 saatte bir 4 dakika süre ile buz uygulanma iyileşmeyi hızlandırır.
- Naylon torbaya konulan buz parçaları bir örtüye sarılarak uygulanmalıdır.

98) Valsalva manevrası nedir? Mekanizmasını açıklayınız.

- Valsalva manevrası yatak içinde kolların yardımı ile üst gövde kaslarının hareket ettirilmesi ve ikinma ile intratorasik basıncın yükselmesidir.
- Valsalva manevrasında solunumun tutulması ile glotis kapanır, intratorasik basınç artar, nabız hızlanır.
- Kalbe dönen kan miktarı azalır ve venöz basınç yükselir.
- Valsalva manevrasının sonunda kişi birden nefesini bıraktığında intratorasik basınç aniden düşer, bradikardi gelişir. Bu durumda koroner kan akımının yavaşlamasına bağlı kardiyak arrest (kalp durması) veya yeni bir emboli gelişebilir. Bu nedenle kalp hastalarının valsalva manevrasını kullanmaları sakıncalıdır.

99) Bası yarası oluşumunu önlenmesinde "deri tolerans testinin" yapıışını ve değerlendirmesini yazınız.

➤ Deri tolerans testi,

bireyin hasar meydana gelmeksizin basıyı ne kadar tolere edebildiğini gösterir. Hastayı çevirdikten sonra yüzeyle temas eden deri bölgesine parmakla hafifçe bası yapılır. Başlangıçta deri beyazlaşır, daha sonra normal rengine döner. Derinin normal rengine dönme süresi bası yapılan sürenin iki katından daha uzun olmamalıdır. Ciltte basmakla beyazlaşmayan (solmayan) eritem veya basınç kaldırılınca kaybolmayan eritem bası yarası gelişeceğini gösterir.

UYKU GEREKSİNİMİ

100) Hastanın normal uyku alışkanlığının ya da herhangi bir uyku sorununun özelliklerini belirlemek için uyku değerlendirmesi nasıl yapılır?

Uykunun niteliğı ve niceliğı hakkında yeterli bilgi bireyin kendisinden alınabilir. Değerlendirmede amaç hastanın normal uyku alışkanlığının ya da herhangi bir uyku sorununun özelliklerini belirlemektir...

- Uyku Hikâyesi:
- Sağlık Durumu:
- Uyku Sorununun Tanılanması:
- Normal Uyku Düzeninin Tanılanması

101) Uyku sorunu saptanan bir hastaya uygulayacağına hemşirelik girişimlerini

- Çevrenin Kontrolü:
- Uykuya Hazırlık Alışkanlıkları:
- Uyku Hijyenine Yönelik Bireyin Yapması Gereken Düzenlemeler:

- Sabahlan uyanınca hemen yataktan çıkılmalıdır. Biraz daha dinlenmek için uyumaya devam etme dinlendirici olmadığı gibi uyku düzenini de bozabilmektedir.
- Her zaman aynı saatte kalkılmalıdır. Uyku düzeninin oluşturulabilmesi için; belirli saatler arasında ve bireysel sirkadiyen ritme göre uyuyabilmesi için en sağlıklı yöntemdir.
- Gündüz uyumamalıdır.
- Düzenli egzersiz yapılmalı, ancak akşam saatlerinde heyecan uyandıracak aktivitelerden kaçınılmalıdır.
- Yatak odası ısı, ışık ve ses yönünden ayarlanmalıdır. Çok aç ya da tok olunmamalıdır.
- Kafeinli, kolali, alkollü içeceklerden kaçınılmalıdır. Uyumaya çabalanmamalıdır.
- Rahatı Destekleme:
- Uyku Düzenine Destek:
- Fiziksel Rahatsızlıkların Giderilmesi:
- Stresi Azaltma:
- Farmakolojik Yaklaşım:
- Yatma Vakti Alışkanlıkları:

102) Uyku sorunu yaşayan hastaya uyku hijyeni konusunda hangi bilgiler verilmelidir?

- Sabahları uyanınca hemen yataktan çıkılmalıdır. Biraz daha dinlenmek için uyumaya devam etme dinlendirici olmadığı gibi uyku düzenini de bozabilmektedir.
- Her zaman aynı saatte kalkılmalıdır. Uyku düzeninin oluşturulabilmesi için; belirli saatler arasında ve bireysel sirkadiyen ritme göre uyuyabilmesi için en sağlıklı yöntemdir.
- Gündüz uyumamalıdır.
- Düzenli egzersiz yapılmalı, ancak akşam saatlerinde heyecan uyandıracak aktivitelerden kaçınılmalıdır.
- Yatak odası ısı, ışık ve ses yönünden ayarlanmalıdır. Çok aç ya da tok olunmamalıdır.
- Kafeinli, kolali, alkollü içeceklerden kaçınılmalıdır.
- Uyumaya çabalanmamalıdır.

103) Aktif dinlenme nedir, örnek vererek açıklayınız.

Aktif dinlenme aktif bir süreçtir. Aktif dinlenme zamanı 5-10 dakikadan 4-5 haftaya kadar sürebilir. Aktif dinlenme aktivitelerine örnekler şunlardır:

- Gevşeme teknikleri (meditasyon, müzik, bulmaca çözme vs.)
- Entelektüel uyarıcı (okuma, yürüme, spor yapma, egzersiz programı vs)
- Fizik aktivite (koşma, yürüme, spor yapma, egzersiz programları vs)
- Yaratıcı aktivite (bahçıvanlık, ağaç işleri, örgü vs)
- Bireysel gereksinimleri karşılama (banyo yapma, alışveriş yapma vs)
- Sosyalizasyon (arkadaşlıklar, klüpler ve dernekler)

URINER SİSTEM

104) Geçici Mesane Kateterizasyonu hangi durumlarda uygulanır?

Mesane distansiyonunun giderilmesi, mesane yetersizliği olan hastaların uzun süreli bakımı için, steril idrar örneği almak, idrar yaptıktan sonra rezidüel idrar olup olmadığını belirlemek.

105) Kalıcı Mesane Kateterizasyonu hangi durumlarda uygulanır?

- İdrar akışında bir tıkanma olduğunda (prostat büyümesi, üretral darlık)
- Üretra ve çevre dokuların onarıldığı cerrahi girişimlerde (transüretral rezeksiyon)
- Üretranın kan pıhtıları ile tıkanmasını önlemede
- Yoğun bakımdaki, durumu ağır olan veya komadaki hastaların çıkarılan saatlik ve günlük idrar miktarını doğru olarak ölçmede
- İdrar inkontinansı olan ve durumu ağır hastalarda idrarın cildi tahriş etmesini önlemede
- Mesane irrigasyonu yapmada
- Papiller mesane karsinomlarının tedavisinde, sitotoksik ilaçları vermede

106) Mesane kateterizasyonunda kadınlar ve erkeklerde kaç numaralı kateter kullanılır?

kadınlarda: 14/16,

erkeklerde: 16/20-11.5.20

107) İdrar retanlyonunda bir defada en fazla kaç cc idrar boşaltılır?

500cc

108) Üretral kateter takarken kadınlarda ve erkeklerde kaç cm ilerletilir?

kadınlarda: 5/7,5cm erkeklerde: 17,5/20cm

109) Üretral kateter takarken kadın ve erkek hastaya hangi pozisyon verilir

Dorsal rekümbent/supine

110) Üretral kateterizasyona bağlı gelişen komplikasyonları söyleyiniz.

- Travma,
- enfeksiyon,
- parafimozis,
- kanama ve
- Mesane Spazmi, sızıntı ve Tıkanma, kateterin Reddi,
- Bolonun söndürülememesi,
- fiziksel ve Psikolojik Zorluklar

111) Orta idrar örneği nasıl ve hangi amaçla alınır?

Üretral yolla mesane kateteri takılmaksızın, üriner sistem dışındaki mikroorganizmalarla kontamine olmamış steril idrar örneği almak için bu yöntem kullanılır. Bu yöntemle alınan idrar örneği, idrar kültürü ve kültür antibiyogram gibi mikrobiyolojik analizlerde kullanılır.

İşlem:

- Onayını almak ve işbirliği sağlamak için yapılacak işlem hastaya açıklanır.
- Gerekli araç-gereç tedavi arabasına hazırlanır ve hastanın odasına getirilir.
- Hastanın gizliliğini sağlamak için perde veya paravana çekilir.

- Hastaya genital alanını açması söylenir.
- Sürgü veya ördek yerleştirilir. Hastanın rahat bir pozisyonda olmasına dikkat edilir.
- Steril eldiven giyilir.
- Kadın hastada üretral meatus ve çevresi antiseptik solüsyonlu (veya sabunlu) tamponlarla önden
- arkaya doğru üç kez silinir.
- Hastaya idrar yapması söylenir.
- ilk akan idrar, üretranın içini yıkayıp bakterilerin sürüklenip atılmasını sağadığı için, sürgüye veya ördeğe akıtılır. Steril idrar kabına ortadaki yaklaşık 30 cc. idrar alınır. Ayrıca idrar kabının genital organlara veya parmakların idrar kabının steril olan iç yüzüne veya ağız kenarına değmemesine dikkat edilmelidir.
- Steril idrar kabının kapağı kapatılır. Steril idrar tüpü kullanılıyorsa üstü steril pamuk tamponla kapatılır.
- İdrar tüpüne veya kabına, üzerinde hastanın adı, idrarın alındığı tarih ve saat yazılı etiket yapıştırılır.
- Yapılan işlem kaydedilir.
- İdrar örneği laboratuvara gönderilir.

112) Üretral kateterizasyonda hasta için uygun numaralı kateter kullanılmadığında hangi komplikasyonlar gelişir?

- üretral mukozada travma (travma)
- Kateterin çevresinden idrar sızması (sızıntı ve tıkanma)
- Kateterin kan pıhtıları veya idrar sedimenti ile tıkanması

113) İdrar örneği alma yöntemlerini sayınız.

Temiz, orta, mesane kateterinden steril, 24 saatlik, iki kez

114) Mesane irrigasyonu türleri nelerdir?

Basit, Aralıklı Mesane Irrigasyonu, Sürekli Mesane Irrigasyonu

115. Üriner kateteri çıkarılması planlanan hastada mesane eğitimi anlatınız.

Kateter çıkarılmadan en az 10 saat önce başlanır. İdrarın mesanede birikmesini sağlamak için kalıcı kateterin klempini kapatılır. Mesanede idrar miktarının artması, mesane duvarlarını gererek kas tonüsünü uyarır. 3 saat sonra kıskaç açılarak, normal idrar yapmaya benzer biçimde 5 dakika süreyle idrarın akması sağlanır. Bu uygulama en az iki kez yapılır.

VÜCUT MEKANİĞİNE UYGUN YATIŞ POZİSYONLARI VE HASTAYI YATAK İÇİNDE HAREKET ETTİRME

116) Hasta bireyler gece uykusu dönemi hariç kaç saatten fazla aynı pozisyonda bırakılmamalıdır?

2 saat

117) Koruyucu Yatış Pozisyonları nelerdir?

1. Sırt üstü (supine) pozisyon

2. Yan (lateral) pozisyon
3. Yüzüstü (prone) pozisyonu
4. Oturur (fowler's)pozisyonu

118) Dorsal Rekümbent pozisyonu ve hangi durumlarda uygulandığını açıklayınız.

Kollar başın arkasına çevrilmiş bacaklar bükük ve yana açık durumdadır. Kadın hastalara idrar sondası takmak için kullanılan pozisyonudur.

119) Litotomi pozisyonunu ve hangi durumlarda uygulandığını açıklayınız.

Hasta sırt üstü yatmış, bacaklar askıda birbirinden açık durumdadır. Vajinal, rektal, üretral tedavi ve muayene pozisyonudur.

120) Ortopne pozisyonunu ve hangi durumlarda uygulandığını açıklayınız.

Kalp ve akciğer yetmezliği olan bireylere verilen pozisyonudur. Hasta yatak içinde oturur durumdadır ve önüne çekilen yemek masasının üzerine konulan yastıkla desteklenir ya da sandalyeye ters oturarak arkalığın üzerine kollarını koyarak, kollarının üstüne yaslanır.

121) Trendelenburg pozisyonunu ve hangi durumlarda uygulandığını açıklayınız.

Hastanın ayakları 30 derece kaldırılır. Başın altından yastık alınır. Özellikle postural drenaj için kullanılır.

122) Yarıyüzüstü (sims') pozisyonunu ve hangi durumlarda uygulandığını açıklayınız.

Hasta yan yatırılır. Bir kol arkadadır, diğer kol önde ve başın yanındadır. Üst bacak iyice karına çekilmiş, alt bacak serbest durumdadır. Bu pozisyon genellikle bilinçsiz hastalarda ağızdan müküs drenajını arttırmak için kullanılır. Eğer ağızdan müküsün drene edilmesini gerektiren bir durum yoksa başın altına küçük bir yastık konularak boynun lateral fleksiyonu engellenmelidir. Bu pozisyon ayrıca rektal, vaginal, kolonun muayenesinde ve lavman uygulamalarında kullanılır.

TERMINAL DÖNEM VE ÖLMEK ÜZERE OLAN HASTA BAKIMI

123) Terminal hasta nedir? Tanımlayınız.

Terminal hasta sözcüğü ile ölümcül bir hastalığı olan ve belirlenebilen bir sürede ölmesi beklenen hasta kastedilir.

124) Kesin ölüm belirtileri nelerdir?

- Kalp atışı ve solunum durmuştur
- Pupiller dilatedir, ışığa reaksiyon yoktur
- Refleksler kaybolmuştur
- Beyin dalgaları (EEG) yoktur

1. "artık hiçbir şey yapılamaz" sözü kabul edilmemeli
2. Amaç yaşamı uzatmak değil, kalan süre içindeki yaşam kalitesini yükseltmektir.

3. Hastanın bakımını planlarken;
 - a. Hastanın konuşması, duygu ve düşüncelerini ifade etmesine olanak sağlanmalı,
 - b. Bakım planı hazırlanırken ailesi, önceden bakım verenler ve doktoru ile konuşulmalı,
 - c. Hastaya ölümü yaklaştığı andan itibaren destek sağlanmalıdır.
 - d. Hemşirenin görevi hastanın bağımsızlığını olabildiğince uzun süre korunmasına yardımcı olmak ve hastaya iyi bir ölüm sağlamaktır.
 - e. Her türlü acı ve rahatsızlık en aza indirilmelidir. f. emşireler hastalar için her an için ulaşılabilir olduklarından hastalara verdikleri bakım özel bir ilişkiye dayanır.

ASEPSİ VE ANTİSEPSİ

126)Çapraz bulaşma nedir? Tanımlayınız.

Hastanede çalışan ve çeşitli virulan suşların doğal taşıyıcısı durumunda olan hekim, hemşire, hizmetli ve diğer görevlilerin bu mikroorganizmaları nasofarenkslerinde taşıyıp damlacıklarla havaya ve doğrudan hastaya vermeleri ya da elleri ve giysileri aracılığı ile enfekte hasta ve kontamine gereçlerden aldıkları mikroorganizmaları diğer hastalara taşımaları yoluyla olan bulaşmalara çapraz (kros) enfeksiyon denir.

127)Tıbbi asepsi ve cerrahi asepsi arasındaki fark nedir?

Tıbbi asepsi (temiz teknik) patojenlerin sayısını azaltan ve yayılmasını engelleyen uygulamaları içerir. Cerrahi asepsi (steril teknik) ise, cisimleri ve bölgeyi bütün mikroorganizmalardan arındırmayı ve bu koşulları devam ettirmeyi sağlayan uygulamaları içerir.

128) Dezenfeksiyon ve sterilizasyon kavramlarını tanımlayınız?

Dezenfeksiyon, bir cisim veya maddede bulunan patojen mikroorganizmaların fiziksel veya kimyasal etkenlerle yok edilmesi işlemidir. Sterilizasyon, bir eşya üzerindeki tüm mikroorganizmaların vegetatif ve sporlu şekillerinin yok edilmesidir.

129)Parenteral ilaç uygulamalarında hangi asepsi türü uygulanır?

Cerrahi

130)Nozokomiyal enfeksiyonun zararları nelerdir?

Hastanede yatan hastalar, belirli bir hastalık nedeniyle yatmışlardır. Organizmalarının normal fonksiyonları bir noktada aksamıştır. Bu duruma eklenen enfeksiyon, hastanın iyileşme şansını daha da azaltır veya tehlikeye sokar. Hastane enfeksiyonları hastanın hastanede yatma süresini uzatır, ihtiyacı olan diğer hastaların hastane yatağından yararlanmasını geciktirir. Ayrıca, iyileşme sürecindeki bir hastada oluşabilecek psikolojik çöküntü, tedavinin etkinliğini azaltabilir. Sağlık yönünden bu kadar zararlı olan hastane enfeksiyonları, gerek ilaç gerekse tıbbi bakım harcamalarını arttırarak büyük ekonomik kayıplara da neden olmaktadır.

131) "Kontaminasyon" ne demektir?

Kontaminasyon, bir cismin kullanım amacı dışında kalacak şekilde mikroorganizmalarla kirlenmesi veya sterilliğinin bozulmasıdır.

132)Antiseptik madde nedir?

Antisepsi, canlı doku üzerinde veya içinde patojen mikroorganizmaların üremelerinin durdurulması veya yok edilmesi sürecidir. Bu amaçla kullanılan maddelere antiseptik madde denir.

133)Steril kavramını tanımlayınız.

Madde üzerinde patojen veya patojen olmayan hiçbir mikroorganizmanın bulunmaması

Canlı mikroorganizmalardan ve virüslerden arındırılmış.

134)Dezenfektan solüsyonların hazırlanma ve kullanım kuralları nelerdir?

ya da

Solüsyonları hazırlandığı kapların veya şişelerin; boş iken yıkanması, olası ise steril edilmesi, içinde solüsyon varken ağzının kapakla sürekli kapalı tutulması, her gün taze olarak hazırlanmaları gerekir. Işıklı etkinliği bozulan solüsyonlar, koyu renkli cam şişelerde tutulmalıdır.

135) "Nozokomiyal enfeksiyon" ne demektir?

hastanede oluşan, ancak hastanın hastaneye girişi sırasında inkübasyonda olmayan enfeksiyondur

136) Tıbbi asepsi ilkeleri nelerdir? 3 tanesini sayınız.

1. Eller sık sık ve özellikle gıdalar ellenmeden önce, yemeklerden önce, mendil kullandıktan sonra, tuvalete girmeden önce ve sonra ve her hastayla temastan önce ve sonra yıkanmalıdır.
2. Kirli araçlar, gereçler ve çarşafalar üniformaya değdirilmeden taşınmalıdır.
3. Kirli yatak çarşafaları ve diğer gereçler asla döşemeye bırakılmamalıdır. Aksi halde her iki yüzey daha fazla kirlenir. Hastaların öksürük, hışırtı ve soluğu ile yüz yüze gelinmemelidir. Bu durumlarda ağız ve burunlarını mendille kapatmaları öğretilir.
4. Araç ve gereçler yıkanırken ve fırçalanırken veya tozu alınırken vücuttan uzakta tutulmalıdır. Böylece kirli maddelerin yıkama suları ile saç, yüze ve üniformaya sıçraması önlenir.
5. Yatak yapma çarçaf değiştirme sırasında toz kaldırmaktan kaçınılmalıdır. Çarşafalar silkelmemelidir. Aksi halde mikroorganizmalar bir yerden başka bir yere hava yoluyla taşınırlar.
6. Temizlik işlemleri sırasında en az kirli bölge önce, çok kirli bölge sonra temizlenmelidir. Böylece kirlerin temiz bölgeye taşınmaları engellenmiş olur.
7. Kirli veya kullanılmış araç ve gereçler doğrudan, onlara özel uygun kapların içine konmalıdır. Vücut atıkları ve akıntılarıyla bulaşmış ıslak gereçler naylon torbalar içine konulduktan sonra kirli arabasına atılmalıdır. Böylece temizlik yapan işçiler onlarla temas etmemiş olur.
8. Banyo veya gargasa suyu gibi kirli sular küvetin kenarına ve üniformaya sıçratılmadan doğrudan kanala dökülmelidir.
9. Patojenlerle kirlendiğinden şüphelenilen gereçler steril edilmeli ve daha sonra temiz gereç gibi kullanılmalıdır.
10. Mikroorganizmaların yayılmaması için bireysel temizlik ve düzene dikkat edilmelidir. Saçlar düzenli bir şekilde yıkanmalı, ya kısa olmalı ya da mikroorganizmaların yerleşmeyeceği şekilde toplu olmalıdır. Tırnaklar kısa ve tırnak uçları pürüzsüz olmalıdır.
11. Mikroorganizmalar için yerleşim yeri olacağından taşlı yüzükler takılmamalıdır.

12. Kuruluşun öngördüğü izolasyon tekniklerine uyulmalıdır.

137) Cerrahi asepsi ilkeleri nelerdir?

1. Steril bir cisim sadece steril bir cisme değebilir. Steril olmayan bir cisim steril bir cisme değdiğinde onu kontamine eder.
2. Steril bir paketin dışı steril değildir. Hemşire paketi açarken, önce kendinden uzak tarafı açmalıdır. Paket yakın taraftan açılırsa, paketin içi hemşirenin üniformasından kontamine olabilir.
3. Steril bir kumaş, ya da kağıt üzerine herhangi bir SIVI sıratılmamalıdır. Mikroorganizmalar, ıslak kumaş ve kağıtta steril olmayan alandan steril alana sızarlar ve kontaminasyona neden olurlar.
4. Hemşire steril cismi bel düzeyinin üzerinde tutmalıdır, böylece kaza ile kontamine olması önlenmiş olur.
5. Steril bir alan ya da cisim üzerine konuşmaktan, öksürmekten, hapşırmaktan, üzerinden el ve kol geçirmekten sakınılmalıdır. Böylece, ağız ve burundaki damlacıkların ya da koldaki bir partikülün steril alan üzerine düşmesi önlenir.
6. Hemşire steril alandan uzaklaşmamalıdır, alana sırtını dönmemelidir. Bu kazara olabilecek kontaminasyonları önlemek içindir.
7. Kesilmiş deriden içeri, sokulan, deriyi delerek içine giren, normalde steril olan vücut boşluklarına yerleştirilen her şeyin steril olması gerekir.
8. Gerektiğinde kuru steril forseps kullanılmalıdır. Dezenfektan içine konan forseps steril olarak kabul edilmez.
9. Eğer bir cismin sterilliğinden en ufak bir kuşku duyuluyorsa, cisim kontamine kabul edilmelidir

138) %20'lik Povidon Iyod solüsyonundan 100 cc. 4'lük Povidon Iyod solusyonu hazırlanması için ilave edilmesi gereken distile su ve %10'luk Povidon Iyod solüsyonunu hesaplayınız.

139) 100 cc. %5'lik NaHCO₃ solüsyonu hazırlanması için ilave edilmesi gereken distile su ve NaHCO₃ miktarlarını hesaplayınız.

140) İzolasyon türleri nelerdir?

- Katı izolasyon,
- Temas, Solunum İzolasyonu,
- Tüberküloz, Enterik, Akıntı-Salgı İzolasyonu,
- Kan-Vücut sıvılarının İzolasyonu

141) Koruyucu Ters izolasyon nedir?

Enfeksiyona karşı direnci zayıflamış olan hastaya olası patojenlerin geçişinin engellenmesidir. Lösemi,

lenfoma, aplastik anemide uygulanır...

YASAMSAL BULGULAR

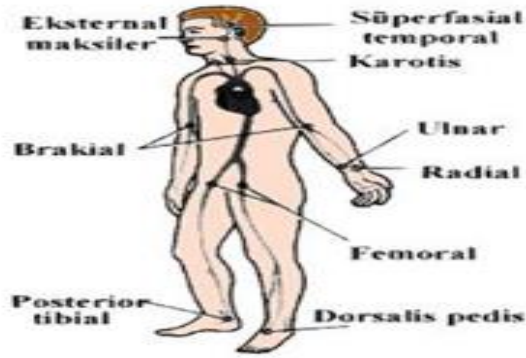
142) Vücut sıcaklığı nedir? Ates nedir? Tanımlayınız.

- Vücut sıcaklığı, vücutta biriken ısı ile doğrudan ilişkilidir. Vücudun iç sıcaklığı, derin dokuların sıcaklığıdır.
- Vücudun iç sıcaklığı 37°C dir.
- Ates (Preks, vücut sıcaklığının yükselmesi, normal sınırların üstüne çıkması anlamına gelir.

143) Nabız alinan periferik arterleri yazınız.

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Temporal arter | 5. Brakial arter |
| 2. Arteria dorsalis pedis | 6. Radyal arter |
| 3. Popliteal arter | 7. Posterior tibial arter |
| 4. Arteria karotis | 8. Femoral arter |

Nabız Alınan Arterler



144) Nabız nedir? Tanımlayınız

kalbin her sistolü sırasında aortaya attığı kanın damar duvarına yaptığı basıncın deri yüzeyinde hissedilmesidir

145) Nabızı değerlendirirken hangi özelliklerine dikkat edilir?

1. Nabız ritmi,
2. Nabız Volümü (Dolgunluğu)
3. Nabız sayısı

146) Kan basıncını tanımlayınız. Kan basıncı ölçümü sırasında dikkat edilecek ilkeleri açıklayınız.

Arteriyel Kan Basıncı: Ventriküllerden arterlere atılan kanın, arter duvarına yaptığı basınçtır. Kan basıncı bir mm²'ye düşen civa basıncı (mmHg) ile ölçülür.

147) Temporal arter termometresi ile vücut sıcaklığı ölçümü nasıl yapılır? Açıklayınız.

➤ Temaslı Temporal Arter Termometresi Vücut Sıcaklığı Ölçümü

- Termometrenin açma düğmesine basılır
- Ekranın açılması beklenir.

- Termometrenin alıcısı alnın ortasında, yüzeyine paralel ve deriye hafifçe dokunacak şekilde tutulur. Düğmeye basmaya devam ederken termometre yavaşça alnın ortasından alnın yan tarafına doğru kaydırılır. Termometre yüzün alt tarafına doğru kaydırılmamalıdır. Bu bölümde arter daha derinde olduğundan sıcaklık yanlış, daha düşük ölçülebilir.
- Düğmeye basma sonlandırılınca bip sesi duyulur ve ölçüm değeri ekranda görülür.
- Yeni ölçüm yapmak için ekrandaki ölçüm değerinin silinmesi beklenir.
- Birey terli ise ölçüm kulak memesinin arkasından yapılır. Ölçümden önce bireyin saçları toplanarak bölge açığa çıkarılır.
- Daha sonra termometrenin alıcısı boynun kulak arkasında, mastoidin üstündeki hafif girintili bölüme getirilir ve 30 saniye bekledikten sonra aşağı-yukarı 1-2 santimetre kadar hareket ettirilerek tarama yapılır.
- Bip sesi gelene kadar bekleyip ölçüm düğmesine basan parmak düğmeden çekilir. Kulak arkasındaki arter doğru ölçüm için uygun bir referans değildir. Ancak terli bireylerde alından yapılacak ölçümlerden daha iyi sonuç verir.

➤ **Temassız Temporal Arter Termometresi ile vücut Sıcaklığı Ölçümü**

Temassız kızılötesi temporal arter termometreler ile yapılan ölçümler temasli termometrelerle benzerdir. Farkı, temassız kızılötesi temporal arter termometre alıcısının deriye temas etmemesidir. Temassız kızılötesi temporal arter termometre alnın ortasında, alıcısı deriden 2,5-10 santimetre (mesofe termometre modeline göre değişebilir) uzaklıkta tutulur, düğmeye bastıktan sonra alnın ortasından alnın yan tarafına doğru kaydırılarak taranır. Hasta terli ise ölçüm kulak arkasından yapılır.

148) Vücut sıcaklığı ölçme yöntem ve araçları nelerdir?

Araçlar:

1. Civalı cam termometreler
2. Tek kullanımlık termometreler
3. Elektronik termometreler
4. Timpanik membran termometreleri.

Yöntemler:

1. Oral yol /Ağız yolu 37
2. Aksiller yol/Koltuk altı yolu 36.5
3. Rektal yol 37.5
4. Timpanik membran /Dış kulak yolu 37
5. Temporal arter/Alın 37

149) Kan basıncını etkileyen etmenler nelerdir?

- Yaş
- Cinsiyet,
- Gün Boyunca Görülen Değişiklikler,
- İlaçlar
- Pozisyon

- Diğer (İrk, iklim, çevre isist, egzersiz, konuşma yemek yeme, uyku, mesanenin dolu ve gergin olması, venöz dönüşü engelleyecek kadar sıkı giysilerin)

150) Kalbin apeksi nasıl tespit edilir?

Sol klavikulanın orta hattından aşağıya doğru elinizle hayali bir çizgi (midklavikular hat) çiziniz. Kalbin apeksi, bu çizginin sol 5. ve 6. kostalar arasındaki boşluk ile kesiştiği noktaya rastlar. Bu nokta sternumdan sola doğru yaklaşık 8 cm. uzaklıkta ve sol memenin altındadır

151) Ateşi olan hastanın bakımını anlatınız.

152) Kan basıncı ölçümünde hangi hataları yaptığımızda kan basıncı düşük çıkar?

Hata

- Ölçüm yapan kişide işitme sorunu olması
- Steteskobun kulaklığının kulağa yanlış yerleştirilmesi
- Kullanılan manometrede sıfır değerinin ayarlanmamış olması
- Çevrede gürültü olması
- Manometrenin göz düzleminden yukarıda olması
- Sfigmomanometrenin bağlantı borularında ya da steteskobun iletim borusunda çatlak olması ya da boruların birbirine dolanması
- Steteskobun alıcısının ölçüm yapılan arterin tam üzerinde olmaması
- Manşonun havasının çok hızlı boşaltılması
- Manşonun en yüksek basınç değerine kadar şişirilmesi

153) Kan basıncı ölçümünde hangi hataları yaptığımızda kan basıncı yüksek çıkar?

Hata

- Kan basıncının herhangi bir fiziksel aktiviteden hemen sonra ölçülmesi
- Manometrenin göz düzleminden aşağıda olması
- Manşetin eninin hastaya göre çok dar olması
- Manşonun havasının çok yavaş boşaltılması
- Manşetin çok gevşek sarılması
- Oskültasyon sırasında manşonun yeniden şişirilmesi

SICAK SOĞUK UYGULAMA

154) Sıcak uygulamanın endike olduğu durumlar nelerdir?

1. Yara iyileşmesini hızlandırmak
2. Ağrıyı azaltmak, kas gerginliğini ve eklem sertliğini azaltmak
3. Vücudun bir bölümünü ısıtmak
4. Ödemi azaltmak

155) Soğuk uygulamanın endike olduğu durumlar nelerdir?

1. Ağrıyı azaltmak
2. İnflamasyon ve süpürasyonu sınırlamak.
3. Kanamayı kontrol etmek

156) Sıcak uygulamaya en fazla kaç dakika devam edilir? Nedenini açıklayınız?

- 20-30 dk.dır.
- Uygulama süresinin uzaması sonucu istenen etkinin tam tersi bir etkinin görülmesine yol açar.(Rebound Fenomeni)

157) Rebound fenomeni nedir?

Sıcak ya da soğuk uygulamalarda uygulama sürenin uzaması sonucu istenen etkinin tam tersi bir etkinin görülmesine Rebound Fenomeni denir

HEMŞİRELİK SÜRECİ

158) Hemşirelik süreci nedir ve hangi aşamalardan oluşur?

Bilimsel problem çözme yönteminin hemşirelik bakımında kullanılmasıdır. Hemşirelik bakımının sunulmasında bireyin sağlığını ya da yaşamını tehdit eden soruna bilimsel yaklaşımlara dayalı çözüm bulan, problemlerin çözümünde kullanılan bir yöntemdir.

1. Verilerin toplanması
2. Sorunun belirlenmesi
3. Hemşirelik girişimlerinin planlanması,
4. Girişimlerin uygulanması
5. Sonuçların değerlendirilmesi

159) Klinik uygulamalarda süreç uygulamasında hangi model ve sınıflama sisteminden yararlanıyorsunuz?

160) Hemşirelik tanı tipleri nelerdir?

1. 1.Mevcut/Gerçek Hemşirelik Tanısı
2. 2.Potansiyel Hemşirelik Tanısı
3. 3.Sendrom Hemşirelik Tanısı
4. 4.Olası Hemşirelik Tanısı